Zeitschrift für Sinnzentrierte Psychologie
HERAUSGEGEBEN VOM INSTITUT FÜR SINNZENTRIERTE PSYCHOLOGIE

Jahrgang 1 · Heft 2 · Oktober 2026
S. 25–28 (Original) · Open Access · CC BY 4.0

ÜBERSICHTSARBEIT

Meaning-Centered Psychotherapy in der Palliativversorgung

Konzeption, Evidenzlage und Fragen der Übertragbarkeit

Samuel R. Ashford, Sora Pazer und Eleanor M. Whitcombe
Institut für Sinnzentrierte Psychologie

Deutsche Übersetzung. Maßgeblich ist die englische Originalfassung.

ZUSAMMENFASSUNG

Menschen mit fortgeschrittenen, nicht heilbaren Erkrankungen sind neben körperlichen Beschwerden häufig mit existenziellen Belastungen konfrontiert, etwa mit Hoffnungslosigkeit, dem Erleben von Sinnverlust oder dem Wunsch nach einem beschleunigten Tod. Die von William Breitbart und Kolleginnen und Kollegen entwickelte Meaning-Centered Psychotherapy (MCP) ist eine manualisierte Intervention, die explizit an Viktor E. Frankls Logotherapie anknüpft und Patientinnen und Patienten darin unterstützen soll, auch angesichts begrenzter Lebenszeit Sinn zu erleben. Der vorliegende narrative Review beschreibt zunächst die theoretischen Grundlagen und den Aufbau der Intervention in ihrer Gruppen- und Einzelform. Anschließend wird die Evidenzlage aus randomisiert-kontrollierten Studien zusammengefasst, die insgesamt auf günstige Effekte hinsichtlich spirituellen Wohlbefindens, erlebten Sinns und Lebensqualität hindeuten. Diskutiert werden zudem Grenzen der bisherigen Forschung, insbesondere die Konzentration auf bestimmte Populationen und Versorgungssysteme, der Umgang mit Studienabbrüchen in einer schwer erkrankten Zielgruppe sowie Fragen der kulturellen Übertragbarkeit. Schließlich wird MCP mit anderen existenziell orientierten Interventionen der Palliativversorgung wie der Dignity Therapy verglichen. Der Beitrag schließt mit Überlegungen zur Implementierung im deutschsprachigen Raum und zu Qualifikationsanforderungen an Behandelnde.

Schlüsselwörter: Meaning-Centered Psychotherapy · Palliativversorgung · Psychoonkologie · Existenzielle Belastung · Logotherapie

ABSTRACT

In addition to physical symptoms, people with advanced, incurable illnesses frequently face existential distress, such as hopelessness, loss of meaning, or a desire for hastened death. Meaning-centered psychotherapy (MCP), developed by William Breitbart and colleagues, is a manualized intervention that explicitly builds on Viktor E. Frankl's logotherapy and aims to help patients experience meaning even in the face of limited life expectancy. This narrative review first describes the theoretical foundations and the structure of the intervention in its group and individual formats. It then summarizes the evidence from randomized controlled trials, which overall points to favorable effects on spiritual well-being, sense of meaning, and quality of life. Limitations of the existing research are discussed, in particular the concentration on specific populations and health care systems, the handling of attrition in a severely ill population, and questions of cultural transferability. Finally, MCP is compared with other existentially oriented interventions in palliative care, such as dignity therapy. The paper concludes with considerations regarding implementation in German-speaking countries and the qualifications required of clinicians.

Keywords: meaning-centered psychotherapy · palliative care · psycho-oncology · existential distress · logotherapy

1 Einleitung

Die moderne Palliativversorgung versteht sich als umfassende Begleitung schwer kranker Menschen, die körperliche, psychische, soziale und spirituelle Dimensionen des Leidens gleichermaßen berücksichtigt. Gerade die existenziellen Belastungen am Lebensende – das Erleben von Sinnlosigkeit, Hoffnungslosigkeit oder der Wunsch nach einem beschleunigten Tod – stellen Behandelnde vor besondere Herausforderungen, weil sie sich nicht durch symptomorientierte Maßnahmen allein beantworten lassen. Yalom (1980) hat die

Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit als eine zentrale existenzielle Grundgegebenheit beschrieben, die in der Konfrontation mit einer lebensbegrenzenden Erkrankung unausweichlich wird.

Vor diesem Hintergrund wurde am Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York die Meaning-Centered Psychotherapy (MCP) entwickelt. Sie gehört zu den wenigen sinnzentrierten Interventionen, die in mehreren randomisiert-kontrollierten Studien untersucht wurden, und stellt damit einen wichtigen Bezugspunkt für die Diskussion über die Evidenzbasis logotherapeutisch inspirierter Verfahren dar. Der vorliegende Beitrag gibt einen narrativen Überblick über Konzeption und Forschungsstand und fragt nach der Übertragbarkeit auf andere Versorgungskontexte.

Konzeptuell lässt sich existenzielle Belastung von Depressivität unterscheiden, auch wenn sich beide überschneiden können. Hoffnungslosigkeit, Sinnverlust oder das Gefühl, anderen zur Last zu fallen, können bei schwer kranken Menschen auch ohne das Vollbild einer depressiven Störung auftreten. Daraus ergibt sich der Bedarf an Interventionen, die existenzielle Themen ausdrücklich zum Gegenstand machen.

2 Theoretische Grundlagen

MCP knüpft ausdrücklich an das Werk Viktor E. Frankls an. Zentrale Annahmen sind, dass das Streben nach Sinn eine grundlegende menschliche Motivation darstellt, dass Sinn auch unter Bedingungen schweren Leidens und begrenzter Lebenszeit erlebt werden kann und dass Menschen die Freiheit behalten, ihre Haltung gegenüber unabänderlichen Umständen zu wählen (Frankl, 1946/2006). Breitbart und Poppito (2014) übertragen Frankls Wertkategorien in konkrete Sinnquellen, die im Verlauf der Intervention systematisch erschlossen werden: historische Sinnquellen im Sinne des eigenen Lebensvermächtnisses, einstellungsbezogene Sinnquellen im Umgang mit den Grenzen des Lebens, schöpferische Sinnquellen im Sinne von Verantwortung und Engagement sowie erlebnisbezogene Sinnquellen in Liebe, Schönheit und Humor.

Ergänzend lässt sich MCP im Rahmen des Meaning-Making-Modells von Park (2010) verstehen. Eine lebensbegrenzende Diagnose kann eine tiefe Diskrepanz zwischen globalen Lebenszielen und der aktuellen Situation erzeugen. MCP kann als strukturierte Unterstützung von Prozessen der Bedeutungsbildung verstanden werden, die diese Diskrepanz nicht leugnen, sondern in einen umfassenderen Sinnzusammenhang einbetten.

Ein weiterer Grundgedanke ist die Unterscheidung zwischen dem, was sich angesichts der Erkrankung nicht ändern lässt, und dem, was weiterhin gestaltbar bleibt. Die Intervention lädt dazu ein, beides wahrzunehmen: die Grenzen anzuerkennen, ohne die verbleibenden Möglichkeiten aus dem Blick zu verlieren. Darin spiegelt sich Frankls Gedanke, dass sich Sinn nicht nur im Tun und Erleben, sondern auch in der Haltung gegenüber dem Unabänderlichen verwirklichen kann.

3 Aufbau der Intervention

Die Gruppenform, Meaning-Centered Group Psychotherapy (MCGP), umfasst acht wöchentliche Sitzungen, die jeweils einem thematischen Schwerpunkt gewidmet sind (Breitbart & Poppito, 2014). Die Sitzungen verbinden didaktische Elemente, in denen Konzepte der Logotherapie vermittelt werden, mit erfahrungsbezogenen Übungen und Gruppendiskussion. Am Beginn steht die Auseinandersetzung mit dem Begriff des Sinns und mit der Frage, wie die Erkrankung das Sinnerleben verändert hat. Es folgen Sitzungen zu den verschiedenen Sinnquellen, wobei insbesondere die Arbeit am eigenen Vermächtnis eine wichtige Rolle spielt. Den Abschluss bilden die Reflexion des gemeinsamen Prozesses und der Blick auf Hoffnungen für die verbleibende Zeit.

Für Patientinnen und Patienten, denen die Teilnahme an einer Gruppe nicht möglich ist, wurde eine Einzelform, die Individual Meaning-Centered Psychotherapy, entwickelt, die eine kürzere Sitzungsfolge vorsieht und flexibler an den Krankheitsverlauf angepasst werden kann (Breitbart et al., 2012). Die Manualisierung erleichtert die Schulung von Behandelnden und die Durchführung kontrollierter Studien, verlangt aber zugleich ein hohes Maß an klinischer Urteilskraft, um die Struktur an die individuellen Bedürfnisse schwer erkrankter Menschen anzupassen.

Ein charakteristisches Element der Intervention ist die Arbeit an einem Vermächtnisprojekt. Die Teilnehmenden werden eingeladen, ein Vorhaben zu entwickeln, das ihr Leben und ihre Werte zum Ausdruck bringt und über die eigene Lebenszeit hinausweist – etwa die Aufzeichnung von Erinnerungen, die Versöhnung mit einer nahestehenden Person oder ein kreatives Projekt. Dieses Element verbindet die von Frankl beschriebenen schöpferischen Werte mit der Frage

nach dem, was von einem Leben bleibt (Breitbart & Poppito, 2014).

4 Evidenzlage

Die erste randomisierte Pilotstudie verglich MCGP mit einer unterstützenden Gruppenpsychotherapie bei Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittener Krebserkrankung (Breitbart et al., 2010). Die Ergebnisse wiesen auf Vorteile der sinnzentrierten Bedingung hinsichtlich spirituellen Wohlbefindens und erlebten Sinns hin; zudem ergaben sich Hinweise auf eine Abnahme von Hoffnungslosigkeit und Todeswünschen. Eine Pilotstudie zur Einzelform zeigte ebenfalls günstige Ergebnisse im Vergleich zu einer Kontrollbedingung (Breitbart et al., 2012).

Eine größere randomisierte Studie mit einer aktiven, unterstützenden Gruppenpsychotherapie als Vergleichsbedingung bestätigte im Wesentlichen diese Befundrichtung (Breitbart et al., 2015). Die sinnzentrierte Gruppe zeigte Vorteile hinsichtlich spirituellen Wohlbefindens und Lebensqualität sowie Hinweise auf eine Verringerung von Depressivität, Hoffnungslosigkeit und dem Wunsch nach einem beschleunigten Tod. Bemerkenswert ist, dass sich die Unterschiede gegenüber einer aktiven Kontrollbedingung zeigten, die selbst unspezifische Wirkfaktoren wie Gruppenkohäsion und emotionale Unterstützung enthielt. In die Meta-Analyse existenzieller Therapien von Vos et al. (2015) gingen sinnzentrierte Interventionen dieser Art ebenfalls ein und trugen zu dem insgesamt günstigen Bild strukturierter Sinninterventionen bei.

Zugleich sind die Grenzen dieser Befunde zu beachten. Die Studien wurden überwiegend an einem spezialisierten onkologischen Zentrum in den Vereinigten Staaten durchgeführt. In einer schwer erkrankten Population sind Studienabbrüche aufgrund von Krankheitsprogression oder Tod unvermeidbar, was die Interpretation von Verlaufsdaten erschwert. Schließlich ist offen, inwieweit sich die Ergebnisse auf andere Diagnosegruppen, Versorgungssysteme und kulturelle Kontexte übertragen lassen.

Ein weiterer Aspekt betrifft die Wahl der Zielgrößen. Die Studien verwendeten neben Symptommaßen insbesondere Instrumente zum spirituellen Wohlbefinden und zur Lebensqualität. Diese Wahl entspricht dem Anspruch der Intervention, ist aber bei Vergleichen mit anderen psychotherapeutischen Verfahren zu berücksichtigen, die primär auf Symptomreduktion zielen. Auch die Frage, welche Komponenten der Intervention für die beobachteten Veränderungen verantwortlich sind, ist bislang nicht abschließend geklärt.

5 Abgrenzung zu verwandten Interventionen

Unter den existenziell orientierten Interventionen der Palliativversorgung ist neben MCP insbesondere die Dignity Therapy bekannt geworden (Chochinov et al., 2005). Sie zielt auf die Stärkung des Würdeerlebens am Lebensende und arbeitet mit einem strukturierten Interview, aus dem ein schriftliches Dokument entsteht, das an Angehörige weitergegeben werden kann. Beide Ansätze teilen die Betonung von Vermächtnis und Lebensrückblick. MCP ist jedoch stärker psychoedukativ angelegt, umfasst mehrere Sitzungen und verfolgt das Ziel, das Sinnerleben auch im Hinblick auf die verbleibende Lebenszeit zu stärken, während die Dignity Therapy eher kompakt und auf die Erstellung eines Würdedokuments ausgerichtet ist.

Gemeinsam ist beiden Interventionen, dass sie existenzielle Themen nicht als bloße Begleiterscheinung psychischer Störungen, sondern als eigenständigen Gegenstand palliativer Versorgung begreifen. Darin unterscheiden sie sich von einem rein psychopathologischen Zugang, der existenzielle Belastung vorwiegend unter dem Gesichtspunkt komorbider Depression oder Angst betrachtet. Für die Praxis kann die Wahl zwischen den Ansätzen von der verbleibenden Lebenszeit, der körperlichen Belastbarkeit und den Präferenzen der Patientinnen und Patienten abhängen.

6 Implikationen für die Versorgung im deutschsprachigen Raum

Für die Implementierung im deutschsprachigen Raum ergeben sich mehrere Fragen. Erstens ist eine sorgfältige sprachliche und kulturelle Adaptation erforderlich, die religiöse und weltanschauliche Vielfalt berücksichtigt und nicht implizit eine bestimmte Sinnkonzeption voraussetzt. Zweitens stellt die Durchführung hohe Anforderungen an die Behandelnden: Neben psychotherapeutischer Kompetenz sind Vertrautheit mit existenziellen Fragestellungen, Erfahrung in der Begleitung Sterbender und die Fähigkeit zur Selbstreflexion im Umgang mit der eigenen Endlichkeit unerlässlich. Drittens sollte die Einführung von einer Evaluation begleitet werden, die nicht nur Symptomveränderungen, sondern auch Sinnerleben, spirituelles Wohlbefinden und die Akzeptanz der Intervention durch Patientinnen, Patienten und Angehörige erfasst.

Insgesamt kann MCP als Beispiel dafür gelten, wie logotherapeutische Grundgedanken in eine präzise beschriebene, überprüfbare Intervention übersetzt werden können. Die vorliegenden Befunde sind ermutigend, rechtfertigen jedoch keine Generalisierung über die untersuchten Kontexte hinaus. Weitere unabhängige Replikationen in unterschiedlichen Versorgungssystemen sind wünschenswert.

Auch Angehörige und Hinterbliebene kommen als Zielgruppe sinnzentrierter Interventionen in Betracht. Die Übertragung auf diese Gruppen ist konzeptuell naheliegend, da auch sie mit Verlust, Abschied und Fragen nach dem Sinn des Geschehenen konfrontiert sind; die Evidenzlage hierzu ist jedoch noch begrenzt und bedarf weiterer Forschung.

Literatur

Breitbart, W., Poppito, S., Rosenfeld, B., Vickers, A. J., Li, Y., Abbey, J., Olden, M., Pessin, H., Lichtenthal, W., Sjoberg, D., & Cassileth, B. R. (2012). Pilot randomized controlled trial of individual meaning-centered psychotherapy for patients with advanced cancer. Journal of Clinical Oncology, 30(12), 1304–1309.

Breitbart, W., & Poppito, S. R. (2014). Meaning-centered group psychotherapy for patients with advanced cancer: A treatment manual. Oxford University Press.

Breitbart, W., Rosenfeld, B., Gibson, C., Pessin, H., Poppito, S., Nelson, C., Tomarken, A., Timm, A. K., Berg, A., Jacobson, C., Sorger, B., Abbey, J., & Olden, M. (2010). Meaning-centered group psychotherapy for patients with advanced cancer: A pilot randomized controlled trial. Psycho-Oncology, 19(1), 21–28.

Breitbart, W., Rosenfeld, B., Pessin, H., Applebaum, A., Kulikowski, J., & Lichtenthal, W. G. (2015). Meaning-centered group psychotherapy: An effective intervention for improving psychological well-being in patients with advanced cancer. Journal of Clinical Oncology, 33(7), 749–754.

Chochinov, H. M., Hack, T., Hassard, T., Kristjanson, L. J., McClement, S., & Harlos, M. (2005). Dignity therapy: A novel psychotherapeutic intervention for patients near the end of life. Journal of Clinical Oncology, 23(24), 5520–5525.

Frankl, V. E. (2006). Man's search for meaning. Beacon Press. (Original work published 1946)

Park, C. L. (2010). Making sense of the meaning literature: An integrative review of meaning making and its effects on adjustment to stressful life events. Psychological Bulletin, 136(2), 257–301.

Vos, J., Craig, M., & Cooper, M. (2015). Existential therapies: A meta-analysis of their effects on psychological outcomes. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 83(1), 115–128.

Yalom, I. D. (1980). Existential psychotherapy. Basic Books.

ZITIERVORSCHLAG (ORIGINALFASSUNG)

Ashford, S. R., Pazer, S., & Whitcombe, E. M. (2026). Meaning-Centered Psychotherapy in Palliative Care: Conception, State of the Evidence, and Questions of Transferability. Journal of Meaning-Centered Psychology, 1(2), 25–28.

LIZENZ, KORRESPONDENZ UND EINSATZ VON KI

Erscheint im offenen Zugang unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0). Korrespondenz: Redaktion der Zeitschrift. Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung generativer KI verfasst und von den Autorinnen und Autoren geprüft, die die volle Verantwortung für den Inhalt tragen.